**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeira do Sul**

Rua Silvio Scopel, 1.200, 5° Andar, 1ª Unidade Cível - Bairro: Santo Antônio - CEP: 96506-630 - Fone: (51)-309-83395 - Balcão Virtual: (51) 9 988-6724 - Email: frcachsul1vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5010168-93.2023.8.21.0006/RS**

**AUTOR**: SILVIA HELENA DE SEABRA TREVISAN

**RÉU**: BRADESCO SAUDE S/A

**RÉU**: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

# SENTENÇA

**i. RELATÓRIO.**

SILVIA HELENA DE SEABRA TREVISAN ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c ação condenatória de pagamento de despesas médicas com pedido de antecipação de tutela de urgência em desfavor da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO e de BRADESCO SAÚDE S.A. Narrou que possui contrato de seguro com o segundo réu, cujo objeto é garantir o reembolso de despesas médico-hospitalares em caso de necessidade de internação ou tratamento ambulatorial. Relatou que necessitou de internação para tratamento de doença crônica, e que após alta hospitalar, foi surpreendida pela cobrança de débito no valor de R$ 67.393,22. Destacou que a cobrança é referente a materiais e medicamentos utilizados no tratamento da requerente, de modo que a cobrança estava sendo realizada pelo primeiro réu. Informou que após entrar em contato com o hospital, foi informada que o BRADESCO SAÚDE S.A., teria rejeitado o pagamento da medicação utilizada pela autora no tratamento, sob o argumento de tratar-se de uso *off-label*. Diante disso, pugnou pelo deferimento da medida liminar para que o primeiro réu (i.) se abstenha de inscrever ou que (ii.) seja retirado o nome da parte autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. Postulou, ao final, pela procedência dos pedidos, a fim de que seja (i.) declararada a inexigibilidade e inexistência do débito em seu desfavor; e (ii.) condenado o segundo réu a realizar o adimplemento integral das despesas médico-hospitalares.

Recebida a petição inicial e deferida tramitação preferencial; indeferido, contudo, o pedido liminar, evento 5, DESPADEC1.

Citado, evento 19, AR1, o BRADESCO SAÚDE S.A. De início, confirmou a existência da apólice, mas ressaltou que o contrato foi firmado em data anterior à vigência da Lei 9.656/98 e não foi adaptado às suas disposições, sendo, portanto, regido por suas condições gerais. Argumentou que a negativa de cobertura foi legítima, pois o uso do medicamento Flebogamma para tratamento de Miastenia Gravis caracteriza-se como *off-label* e, portanto, experimental. Afirmou que tratamentos experimentais estão expressamente excluídos da cobertura contratual, conforme a cláusula 3ª das condições gerais da apólice. Sustentou, ainda, que o diagnóstico da autora era, à época da internação, apenas uma hipótese, o que reforçaria o caráter experimental do tratamento, e que as autorizações das operadoras de saúde no Brasil têm como base de análise órgãos reguladores nacionais, não constituindo diretriz para autorização de insumos e medicamentos em território nacional qualquer outra referência bibliográfica ou *guideline* internacional. Pugnou pela improcedência dos pedidos, evento 22, CONT1.

Houve réplica, evento 25, RÉPLICA1.

Citada, evento 20, AR1, a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO apresentou contestação e reconvenção. No mérito da ação principal, alegou que os serviços médico-hospitalares foram prestados e que a autora, ao ser admitida, firmou contrato de prestação de serviços e termo de ciência, por meio dos quais assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas que não fossem cobertas pelo seu plano de saúde. Defendeu a legitimidade da cobrança, uma vez que, diante da negativa de cobertura pela seguradora, a obrigação de pagamento recai sobre a paciente, tomadora dos serviços. Argumentou que não possui relação jurídica material direta com o co-réu BRADESCO SAÚDE S.A. que tornasse legítima a cobrança diretamente da seguradora, salientando que a relação contratual de prestação de serviços hospitalares é única e exclusivamente formalizada entre o Hospital e o paciente atendido. Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação da autora ao pagamento do débito, atualizado para R$ 72.361,47 ou, alternativamente, na hipótese de se entender que o plano de saúde teria obrigação de cobrir o exame em questão, que a condenação ao pagamento recaísse sobre o co-réu BRADESCO SAÚDE S.A., a ser efetuado diretamente em seu favor, evento 40, CONT1.

Houve réplica e contestação à reconvenção. A parte autora postulou pela improcedência da reconvenção pelos memos argumentos apresentados na ação principal; ou seja, a inexigibilidade da cobrança em face dela, em razão da responsabilidade da seguradora, evento 46, RÉPLICA1.

Recebida a reconvenção, evento 65, DESPADEC1.

Sobreveio réplica à contestação da reconvenção, evento 73, RÉPLICA1.

As partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, evento 77, DESPADEC1.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

**ii. FUNDAMENTAÇÃO.**

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois (i.) a parte autora é destinatária final do serviço prestados pela parte ré no mercado de consumo. Assim, a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor disposto no art. 2º do CDC, o qual diz que

> *Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.*
> *Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.*

Por outro lado, (ii.) a parte ré, por ser prestadora de serviço — natureza securitária e hospitalar — no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, segundo o qual,

> *Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Ademais, consoante orientação contida no enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça,

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Assim, a súmula confirma o entendimento de que a relação entre o beneficiário e a operadora de planos de saúde é uma relação de consumo, sujeita às regras e proteções do Código de Defesa do Consumidor.

A principal ressalva é a exclusão dos planos administrados por entidades de autogestão, que são aqueles criados e mantidos por empresas, associações ou sindicatos para assistência exclusiva de seus membros e dependentes, sem fins lucrativos e sem oferta ao público em geral.

As cláusulas contratuais, portanto, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e sob a ótica da boa-fé contratual, incidindo o disposto no art. 51, §1º, III, do CDC, segundo o qual

> *São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:*
> *(...)*
> *§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:*
> *(...)*
> *III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.*

Ao tratar da matéria, DANIELA BATALHA TRETTEL leciona que

> *O Código de Defesa do Consumidor foi um divisor de águas na defesa do usuário de planos de saúde diante das práticas restritivas de direito das operadoras de planos de saúde. Em vigor a nova lei, começou o debate acerca da sua aplicabilidade aos contratos anteriores a ela. Contratos anteriores à vigência do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça entende que o contrato de plano de saúde é contrato de trato sucessivo, caracterizado pela prestação continuada no tempo, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável aos fatos que ocorreram após a sua entrada em vigor. 'a questão fundamental a ser dirimida é sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o contrato é anterior. (TRETTEL, Daniela Batalha, Planos de Saúde na Visão doSTJ e do STF. São Paulo: Verbatim, 2010, p.33)*

A própria natureza dos planos de saúde faz com que os consumidores os busquem visando segurança, previsibilidade e proteção contra eventuais problemas futuros, colocando o segurado em situação de evidente vulnerabilidade perante os fornecedores desses serviços de saúde.

A importância de tais valores objetivados na relação contratual foi acentuada pela doutrina de CLÁUDIA LIMA MARQUES:

> *O objeto principal destes contratos é a transferência (onerosa e contratual) de riscos referentes a futura necessidade de assistência médica ou hospitalar. A efetiva cobertura (reembolso, no caso dos seguros de reembolso) dos riscos futuros à sua saúde e de seus dependentes , a adequada prestação direta ou indireta dos serviços de assistência médica (no caso dos seguros de pré-pagamento ou de planos de saúde semelhantes) é o que objetivam os consumidores que contratam com estas empresas. Para atingir este objetivo os consumidores manterão relações de convivência e dependência com os fornecedores desses serviços de saúde por anos, pagando mensalmente suas contribuições, seguindo as instruções (por vezes, exigentes e burocráticas) regulamentadoras dos fornecedores, usufruindo ou não dos serviços, a depender da ocorrência ou não do evento danoso à saúde do consumidor e seus dependentes (MARQUES, Cláudia Lima. "Contratos no Código de Defesa do Consumidor - Contratos submetidos às regras do CDC - Contratos de Seguro, planos de saúde, Revista dos Tribunais, 2005, p. 489)*

No tocante ao direito à saúde suplementar, que pertence ao mercado privado e envolve operação de planos ou seguros de saúde, os quais estão sob fiscalização estatal e judicial.

Na espécie, os contratos de seguro, em geral, centram-se na segurança jurídica dos negócios jurídicos firmados; ou seja, baseiam-se em riscos advindos das próprias informações prestadas pelos segurados, e não em incertezas, bem como diante da maior ou menor procura de medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos.

Assim, não se pode permitir que uma obrigação inicial se entenda como obrigação restrita e absoluta, especialmente considerando a vasta quantia de tratamentos, doenças, medicamentos que são estudados e passam ao cotidiano das pessoas.

Não é viável, portanto, reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Em razão disso, em 21/09/2022, sobreveio a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, no seguinte sentido:

> *Art. 10. (...)*
> *(...)*
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Por conseguinte, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS detém a atribuição de aprovar resolução normativa a respeito dos procedimentos e eventos em saúde que orienta a cobertura mínima que as operadoras de plano de saúde devem oferecer aos beneficiários.

Neste ponto, a ANS aprovou, em 24/02/2021, a Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, definindo, os novos exames e tratamentos que passam a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde, guardadas as obrigações respectivas nos contratos de planos de atendimento ambulatorial, nos de internação hospitalar, os com obstetrícia e os com atendimento odontológicos.

O mencionado rol, além de estabelecer a cobertura mínima a ser observada nos planos de saúde, define a classificação dos procedimentos, bem como eventuais carências que devem ser observadas, atendendo, na integralidade, as disposições da Lei 9.656/98.

Nesse contexto, dispõe o art. 2º da RN 465/2021 que

> *Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.*

Portanto, o rol da ANS estabelece as coberturas mínimas a serem disponibilizadas pelas operadoras de plano de saúde, cabendo, contratualmente, de forma voluntária entre as partes, prever coberturas outras, além de eventuais coparticipações.

Por conseguinte, sendo caso de cobertura obrigatória nos termos das diretrizes normatizadas pela ANS, é ilícita a cláusula contratual que disponha a respeito de exclusão do tratamento, notadamente quando presente a cobertura legal para a patologia apresentada.

Isso porque cabe ao médico assistente definir qual o melhor tratamento ao beneficiário, devendo ser assegurada a cobertura contratual prevista para a doença e não a escolha pelo tratamento em si ministrado.

Com efeito, eventual argumentação da operadora de plano de saúde ou de seguro, a respeito de inexistência de comprovação da eficácia do tratamento e sua imprescindibilidade, foge de sua competência, cabendo a escolha apenas ao médico assistente da parte beneficiária.

Orientação que ficou bem ilustrada no julgamento do AgInt no AREsp 1198799/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. RADIOTERAPIA. QUIMIOTERAPIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.*

<u>No caso dos autos</u>, é fato incontroverso a relação jurídica de caráter securitário mantida entre a parte autora e a co-ré BRADESCO SAUDE S/A.

Ademais, ficou demonstrado que o medicamento Flebogamma (Imunoglobulina Humana) possui registro na ANVISA sob o n.º 136410002:

**Consultas**

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: FLEBOGAMMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome da Empresa Detentora do Registro** | GRIFOLS BRASIL LTDA | **CNPJ** | 02.513.899/0001-71 | **Autorização** | 1.03.641-7 |
| **Processo** | 25351.001663/0075 | **Categoria Regulatória** | Similar | **Data do registro** | 19/09/2000 |
| **Nome Comercial** | FLEBOGAMMA | **Registro** | 136410002 | **Vencimento do registro** | 09/2025 |
| **Princípio Ativo** | IMUNOGLOBULINA HUMANA | | | **Medicamento de referência** | - |
| **Classe Terapêutica** | IMUNOGLOBULINAS | | | **ATC** | |
| **Parecer Público** | - | | | **Bulário Eletrônico** | Acesse aqui |
| **Rotulagem** | | | | | |

Ocorre que, ainda que a parte ré tenha alegado que o fármaco não possui cobertura assegurada pela ANS para a moléstia que acomete a parte autora, pois considerado como uso *off label,* não cabe à seguradora limitar o tratamento da parte segurada.

Isso porque, como já exposto, tal determinação somente caberia ao médico conhecedor das peculiaridades do quadro clínico do seu paciente; tal como ocorreu no caso dos autos.

Orientação que, além de adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, ecoa no Tribunal de Justiça Gaúcho, podendo-se citar, a título exemplificativo, a Apelação Cível 50006046220228210059, Rel. Des. GELSON ROLIM STOCKER:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras. - É indevida a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do procedimento prescrito pelo médico, mesmo sendo ele off label, quando necessário ao tratamento de enfermidade que seja objeto de cobertura pelo contrato. Caso em que devido o procedimento solicitado pela autora, uma vez que constante do Rol da ANS, ainda que para neoplasia diversa. - A negativa ofertada pela ré foi fundamentada no fato de que os procedimentos solicitados estavam em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS e, nesse contexto, a operadora do plano de saúde, em atenção ao contrato, não estava obrigada a custear o tratamento, destacando que o medicamento não encontrava correlação para com o tipo de câncer / neoplasia. Sentença de procedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME".*

Conforme declaração do médico responsável pelo tratamento da parte autora, Dr. Fernando Kowacs, o tratamento com imunoglobulina humana intravenosa foi bem-sucedido, evento 46, RECEIT2:

> A pedido da paciente Silvia Helena de Seabra Trevisan, e para apresentação ao seu provedor de saúde suplementar e/ou ao Poder Judiciário, justifico a prescrição de curso de 5 dias de imunoglobulina humana intravenosa IGIV (prevsto no PCDT do MS), durante internação no Hospital Moinhos de Vento, ocorrida na segunda quinzena de setembro de 2023 por instalação de quadro de disartria e disfagia de progressão rápida, com achados de ENMG compatíveis com miastenia gravis, CID-10: G70.01(posteriormente confirmada positividade para anticorpos anti-receptor da acetilcolina no soro).
> O tratamento agudo com plasmaferese foi bem sucedido, tendo interrompido a progressão dos sintomas e eliminado o risco de aspiração pulmonar de líquidos ou alimentos sólidos. Desde lá, a paciente vem tendo boa evolução, com o uso continuado de piridostigmina.

Assim, além de corroborar a prescrição por médico assistente, estão preenchidos os requisitos previstos pelo art. 10, §13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, o que enseja o reconhecimento do dever de cobertura do procedimento médico pela requerida:

> *É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> *(...)*
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Unico de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Nesse sentido, cita-se a decisão proferida na Apelação Cível 51223166220238210001, Rel. Des. MAURO CAUM GONÇALVES:

> *APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA DE ESTÁGIO 5. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM IMUNOGLOBINA HUMANA ENDOVENOSA (IGIV) RITUXIMABE. DEVER DE COBERTURA. USO OFF LABEL. REGISTRO PELA ANVISA. OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE DEVEM SER INTERPRETADOS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ISTO É, DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. CONTEXTO EM QUE RESTOU COMPROVADA A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS E NO FATO DE SER MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL. POSICIONAMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DA OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE CUSTEIO/FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, AINDA QUE DE USO OFF-LABEL, REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.*

Em suma: a negativa de ressarcimento securitário da co-ré BRADESCO SAUDE S/A, em favor da parte autora, mostra-se descabida.

Primeiro, porque há cobertura securitária para a doença que acometia a parte autora.

Segundo, porque o medicamento encontra-se regulamentado pela ANVISA.

E, não bastasse isso, porque não há dúvida quanto à necessidade do tratamento prescrito pelo médico que acompanhava a paciente, que é profissional habilitado para definir o tratamento mais adequado.

É caso, portanto, de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, no sentido de condenar o réu BRADESCO SAUDE S/A ao pagamento da indenização securitária relativa ao tratamento médico da parte autora, evento 1, OUT7.

Por consequência, reconhecida a ausência de responsabilidade da parte autora em relação ao pagamento das despesas médicas, impõe-se o parcial acolhimento da reconvenção apresentada, a fim de que o BRADESCO SAUDE S/A seja condenado ao pagamento da indenização securitária relativa ao tratamento médico da parte autora.

**iii. DISPOSITIVO.**

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, acolho os pedidos formulados por SILVIA HELENA DE SEABRA TREVISAN em desfavor de ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO e de BRADESCO SAÚDE S/A para, julgando o processo com resolução de mérito,

> *⇒ reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$ 67.393,22 em face da parte autora; e, por consequência,*
>
> *⇒ condenar o réu BRADESCO SAÚDE S/A a realizar o adimplemento integral das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 67.393,22, evento 1, OUT7.*

Sucumbente, condeno o réu BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido, consistente no montante que a parte autora não precisará desembolsar, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, acolho parcialmente a reconvenção apresentada pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO, a fim de condenar o réu BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento do débito diretamente ao hospital credor, no valor de R$ 67.393,22, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o réu BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento das custas processuais da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios em favor da parte reconvinte, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, o qual deverá ser atualizado pelo IPCA, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

---

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BOCK, Juiz de Direito**, em 01/12/2025, às 22:51:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10087355382v47** e o código CRC **72ea1574**.

---